

irAEs — PENSAR, GRADUAR, CORTICOIDE

O QUE SÃO E QUANDO SUSPEITAR

Aspecto	Detalhe
Mecanismo	Inibidores de checkpoint (anti-PD-1/PD-L1, anti-CTLA-4) desinibem o sistema imune -> inflamação autoimune em qualquer órgão
Exemplos de drogas	Nivolumabe, pembrolizumabe (anti-PD-1); atezolizumabe (anti-PD-L1); ipilimumabe (anti-CTLA-4)
Quando suspeitar	Qualquer sintoma novo em paciente em imunoterapia (atual ou recente) = irAE até prova em contrário
Tempo	Pode surgir a qualquer momento, inclusive SEMANAS a MESES após a última dose
Diferente da quimio	Não é toxicidade citotóxica clássica — é inflamação imunomediada (tratada com imunossupressão)
Princípio	Reconhecer cedo, graduar e tratar com corticoide; excluir outras causas (infecção, progressão)

irAEs POR ÓRGÃO — PRINCIPAIS

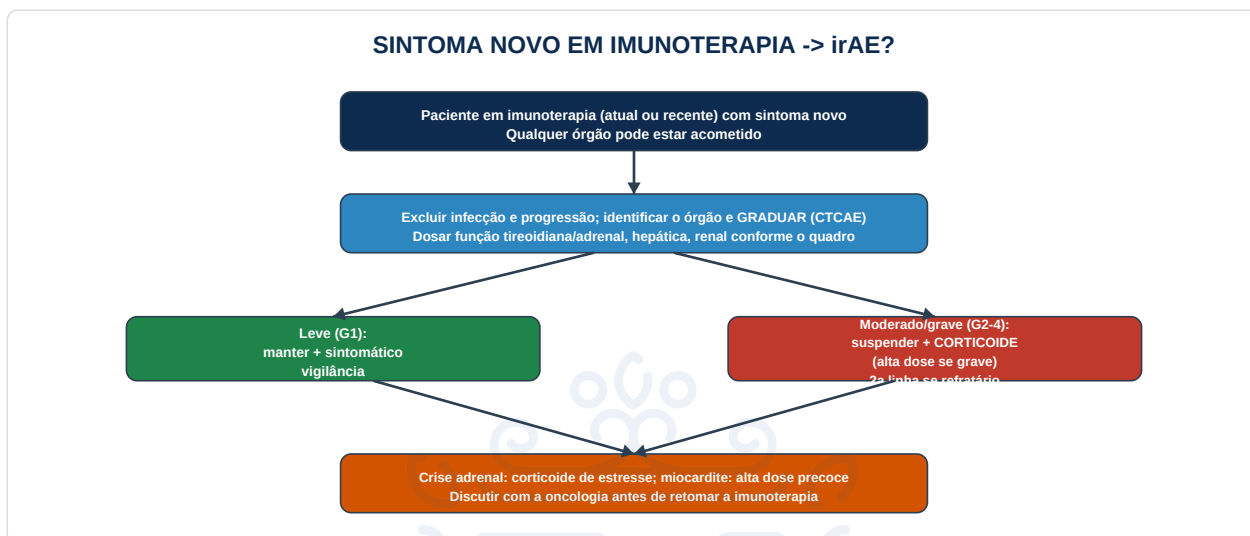
Órgão	Manifestação	Atenção
Cólon	Colite/diarreia (frequente e potencialmente grave)	Risco de perfuração; excluir C. difficile
Pulmão	Pneumonite (dispneia, tosse, hipoxemia)	Pode ser fatal; excluir infecção/progressão
Fígado	Hepatite (elevação de transaminases)	Geralmente assintomática inicialmente
Endócrino	Hipofisite, tireoidite, insuficiência adrenal, diabetes (CAD)	Insuficiência adrenal pode ser fatal
Pele	Rash, prurido; raramente Stevens-Johnson	Forma grave exige suspensão e corticoide
Outros (raros e graves)	Miocardite, miastenia/miosite, encefalite, nefrite	Miocardite tem alta letalidade — alto índice de suspeita

PRINCÍPIO DO TRATAMENTO: CORTICOIDE CONFORME O GRAU

GRADUAR (CTCAE) E IMUNOSSUPRIMIR; EXCLUIR INFECÇÃO

- Grau 1 (leve): geralmente manter a imunoterapia com vigilância e tratamento sintomático
- Grau 2 (moderado): suspender temporariamente o checkpoint + corticoide (prednisona ~0,5-1 mg/kg/dia)
- Grau 3-4 (grave): SUSPENDER (muitas vezes em definitivo) + corticoide em ALTA dose (metilprednisolona 1-2 mg/kg/dia) + internação
- Refratário ao corticoide em 48-72h: imunossupressor de segunda linha (ex.: infliximabe na colite; NÃO usar infliximabe na hepatite)
- Insuficiência adrenal / crise adrenal: corticoide em dose de estresse — NÃO confundir com outras irAEs (pode ser fatal se não tratada)
- Miocardite por checkpoint: rara, mas com alta letalidade — corticoide em alta dose precoce, suporte e monitorização
- Sempre EXCLUIR infecção e progressão da doença antes/junto de assumir irAE

ABORDAGEM DA SUSPEITA DE irAE



ARMADILHAS E CASOS GRAVES

Não Errar

- Atribuir o sintoma à 'quimio' e não pensar em irAE
- Esquecer a insuficiência adrenal/hipofisite (fadiga, hipotensão, hiponatremia) — risco de crise adrenal
- Não excluir infecção antes de imunossuprimir (sobretudo na pneumonite/colite)
- Subestimar a colite (risco de perfuração) e a pneumonite (risco de insuficiência respiratória)
- Usar infliximabe na hepatite imunomediada (contraindicado — hepatotóxico)
- Demorar para iniciar corticoide nas formas graves

irAEs de Alta Gravidade

- Miocardite: dor torácica, dispneia, troponina/ECG alterados — alta letalidade
- Pneumonite grave: hipoxemia — corticoide em alta dose + suporte
- Colite grave: diarreia intensa, dor, risco de perfuração
- Crise adrenal: hipotensão, hiponatremia, hipoglicemia — corticoide de estresse imediato
- Encefalite/miastenia/Guillain-Barré-like: avaliação neurológica urgente
- CAD por diabetes autoimune induzido — tratar a CAD + insulina

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Sintoma novo em paciente em imunoterapia (mesmo semanas-meses após) = irAE até prova em contrário
- ☐ Identificar o órgão acometido e GRADUAR (CTCAE); excluir infecção e progressão
- ☐ Grau 1: manter + sintomático; Grau 2: suspender + corticoide; Grau 3-4: suspender + corticoide em alta dose + internar
- ☐ Refratário em 48-72h: 2a linha (ex.: infliximabe na colite — NÃO na hepatite)
- ☐ Pensar e tratar insuficiência adrenal/hipofisite (corticoide de estresse) e miocardite (alta letalidade)
- ☐ Discutir com a oncologia a suspensão/retomada da imunoterapia

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente em uso de pembrolizumabe há 2 meses chega com diarreia intensa e dor abdominal. Qual a principal hipótese e a conduta?

- A) Gastroenterite viral — apenas hidratação
- B) Colite imunomediada (irAE) — excluir infecção (C. difficile), suspender o checkpoint e iniciar corticoide conforme a gravidade
- C) Progressão tumoral — sem tratamento
- D) Constipação — laxativo
- E) Síndrome do intestino irritável

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tratamento de base da maioria dos eventos adversos imunomediados moderados a graves?

- A) Antibiótico de amplo espectro
- B) Corticoide (imunossupressão), conforme o grau, suspendendo o checkpoint
- C) Quimioterapia citotóxica
- D) Anti-histamínico
- E) Apenas observação

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que a fadiga intensa com hipotensão e hiponatremia em paciente em imunoterapia não pode ser negligenciada?

- A) Porque indica progressão tumoral apenas
- B) Porque pode ser insuficiência adrenal/hipofisite (irAE endócrina), com risco de crise adrenal fatal — exige corticoide de estresse
- C) Porque é um efeito esperado e benigno
- D) Porque indica boa resposta ao tratamento
- E) Porque é sempre desidratação simples

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Paciente em imunoterapia com dispneia e hipoxemia novas. Qual irAE grave deve ser considerada e o que excluir?

- A) Pneumonite imunomediada — excluir infecção e progressão; corticoide em alta dose se grave
- B) Rinite alérgica — anti-histamínico
- C) Ansiedade — ansiolítico
- D) Asma leve — broncodilatador apenas
- E) Refluxo — inibidor de bomba

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Quando deve-se suspeitar de irAE em um paciente que recebeu imunoterapia?

- A) Apenas durante a infusão
- B) Diante de qualquer sintoma novo, mesmo semanas a meses após a última dose
- C) Somente nas primeiras 24 horas
- D) Apenas se houver febre
- E) Nunca, pois a imunoterapia não causa toxicidade

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Diarreia/dor abdominal em paciente em anti-PD-1 sugere colite imunomediada (irAE), potencialmente grave (risco de perfuração). Conduta: excluir infecção (*C. difficile*), suspender o checkpoint e iniciar corticoide conforme a gravidade; infliximabe se refratária.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O tratamento de base da maioria dos irAEs moderados a graves é a imunossupressão com corticoide, conforme o grau (CTCAE), suspendendo temporária ou definitivamente o inibidor de checkpoint. Casos refratários usam segunda linha (ex.: infliximabe).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Fadiga + hipotensão + hiponatremia em imunoterapia pode indicar insuficiência adrenal/hipofisite (irAE endócrina), com risco de crise adrenal fatal. Exige reconhecimento precoce e corticoide em dose de estresse, além de avaliação endócrina.

QUESTÃO 4 → Resposta: A

Dispneia e hipoxemia novas em paciente em imunoterapia devem levantar a suspeita de pneumonite imunomediada (potencialmente fatal). Deve-se excluir infecção e progressão e, nas formas graves, iniciar corticoide em alta dose com suporte.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Deve-se suspeitar de irAE diante de QUALQUER sintoma novo em paciente que recebeu imunoterapia, inclusive semanas a meses após a última dose, pois os eventos imunomediados podem surgir de forma tardia e em qualquer órgão.

SM24
Suporte ao Plantão Médico